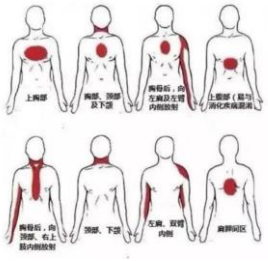
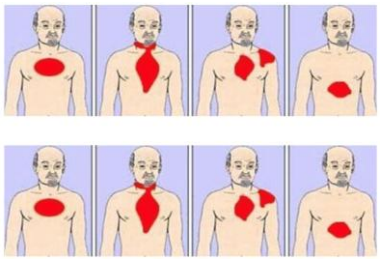
阳间病例题:说了一堆无胸痛表现不优先考虑冠心病
阴间病例题:不能因为没说胸痛就排除冠心病

（二）稳定型心绞痛的特点

①**有明显诱因** 若睡觉时出现心绞痛肯定不是稳定型心绞痛(无诱因)
②性质为钝痛，常伴**压榨/压迫**、发闷、紧缩感，可有烧灼感，偶伴濒死感
③主要为**胸骨后疼痛**，可波及心前区，常放射至颈部、左肩、左臂内侧等；也有患者仅有胸闷 放射痛无特异性
④持续时间短（多 3-5 分钟），**不超过 30 分钟** >30分钟考虑心肌梗死
⑤休息或舌下含服(避免首过消除)硝酸甘油易缓解 扩冠脉→增加心肌供氧;扩静脉→减少回心血量减少心肌耗氧
⑥发作的频率、程度、持续时间、性质、诱因等在**数个月内无明显变化** 斑块引起固定狭窄 稳定型心绞痛的本质

（三）发作时的其它表现

（1）心率↑、血压↑、外周动脉压↓ 交感神经兴奋 阻力血管收缩,流向外周血↓
（2）手脚冰凉、出汗 皮肤血流量↓ 兴奋交感N

（3）左心室功能障碍等心肺顺应性下降的体征 VS 扩心病:室壁收缩普遍/弥漫减弱
①心肌缺血→左心室收缩力和收缩速度↓→左心室壁收缩不协调（室壁收缩**节段**性减弱）
②心肌缺血→左心室收缩力和收缩速度↓→搏出量↓→左心室舒张末压↑→肺毛细血管压和肺动脉压↑
③心肌缺血→室壁比正常人“僵硬”→血流冲击下产生变异的 S_3（S_3 奔马律）
④心肌缺血→搏出量下降→左心室舒张末压↑→心房为克服充盈阻力而加强收缩→S_4 增强（S_4 奔马律）
⑤心肌缺血→左心室收缩速度↓→左心室射血时间比右心室长→主动脉瓣关闭比肺动脉瓣关闭延迟→S_2 逆分裂（若病变累及右室则导致 S_2 通常分裂）

（4）暂时性心尖部收缩期杂音 乳头肌缺血→乳头肌功能失调→二尖瓣关闭不全
稳定型心绞痛休息后好转

（四）稳定型心绞痛缓解期的治疗

1.改善缺血、减轻症状
①硝酸酯类 若患者心率只有60次/分,仍能用β-R拮抗剂:①本来就需要降心率至55-60次/分②很严重的缓慢型心律失常(如严重窦性心动过缓、病态窦房结综合征、二度II型和三度房室阻滞)才禁用
②β-R 拮抗剂：用药后静息心率降至 55-60 或 50-60 次/分。**高血压伴稳定型心绞痛首选 β-R 拮抗剂、次选 CCB**
③CCB 窦房结P细胞4期自动去极化最快(自律性最高):IK↓(主要)、If和ICa-T↑、INa-Ca 降低猝死概率
④**伊伐布雷定**（选择性窦房结 If 电流抑制剂以减慢窦性心率）、**雷诺嗪**（抑制晚期钠电流以防止钙超载）、曲美他嗪（提高氧利用率）、尼可地尔（扩张微血管） β-R拮抗剂不适合就用它 2期(平台期):ICa-L(CICR)、IK1、IK、INa,late、INa-Ca
针对血管平滑肌上的一种钾通道,使其开放→钾外流→细胞膜超极化→影响电压门控钙通道的开放

2.**预防心梗、改善预后**（没有硝酸酯类）AB板子
（1）**β-R 拮抗剂**
（2）**ACEI/ARB/ARNI**：特别适合伴糖尿病(增敏胰岛素)、蛋白尿(保护肾脏)、慢性心衰、高血压、痛风（ARB）(促进尿酸排泄) 抗重构